

اسم المريض ربيعاً : نجاه توفيق زكى سعد

الحي / المدينة : عين شمس

المحافظة : القاهرة

رقم البطاقة : 26604092100325 رقم التلفون : 01148780966

العمر (تاريخ الميلاد) : 09-04-1966 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام رنين مغناطيسي على الفقرات الصدرية [12771] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

التعليق على التشخيص : -----

الاسم: د/محمد كيلاي	الوظيفة: _____	التوقيع: _____
الاسم: د/ندي حسن	الوظيفة: _____	التوقيع: _____
الاسم: د/نرمين رمضان	الوظيفة: _____	التوقيع: _____

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

-----/د -----/د -----/د.ا -----/د.ا

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدیر عام

مديرية الشئون الصحية

رئيس

المجلس الطبي المتخصص

Name: نجاه توفيق زكي سعد
National ID: 26604092100325



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ ومساءة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ ومساءة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي MRI of the thoracic spine.

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مطابق تطبيق الشخصية



الرقم
العرفي
الخاص
بالهوية

٢ ٦ ٦ . ٤ . ٩ ٢ ١ . ٠ ٠ ٣ ٢ ٥

LV4586504



٢٠٢٦/٠٧

٢٦٦٠٤٠٩٢١٠٠٣٢٥

بدون عمل

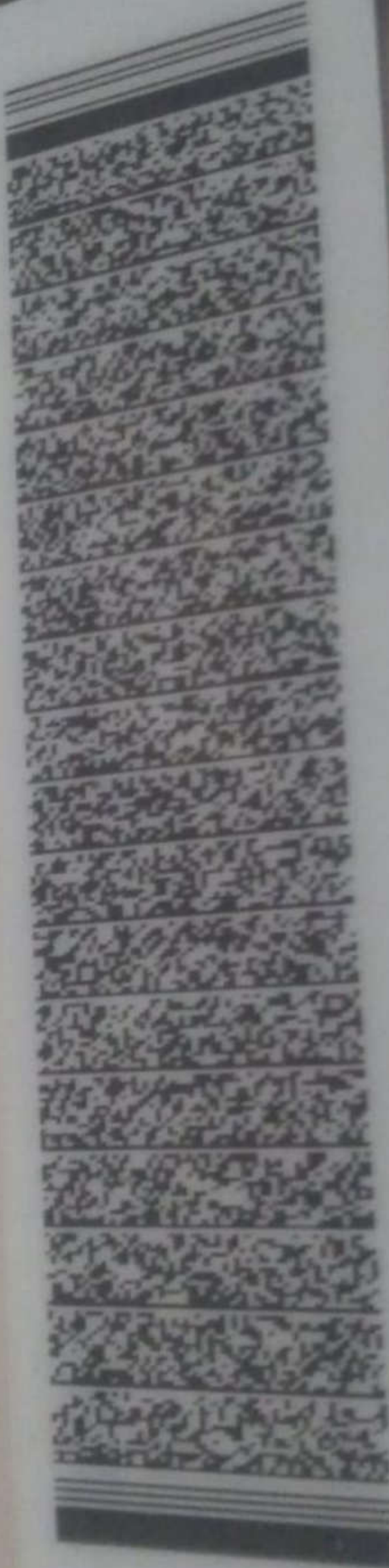
متزوجة

مسلمة

انثى

حامد بدوى احمد الحليوى

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٧/٠٩



Name: نجاه توفيق ذكى سعد		
MR. : 12976		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر ف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 60-year-old individual who is post-menopausal and has a past medical history of hypertension. There is no reported family history of breast or related malignancies. Core needle biopsy of the right breast lesion demonstrated invasive ductal carcinoma, grade 1. Immunohistochemistry showed strong estrogen receptor positivity (8/8), strong progesterone receptor positivity (8/8), HER2 score 0, and a Ki-67 proliferation index of 15%. Imaging with sonomammography identified a right-breast mass measuring 12 × 8 mm. Staging investigations revealed a small lytic lesion in the vertebral body on CT of the chest, abdomen, and pelvis, and a bone scan demonstrated multiple focal lesions that are highly suspicious for metastatic bone disease. The referring team recommended proceeding with systemic therapy appropriate for hormone-receptor-positive, HER2-negative disease with consideration of bone-directed treatment given the suspected skeletal metastases. The multidisciplinary team concurred with these recommendations and planned to initiate endocrine therapy combined with a bone-modifying agent, while arranging further multidisciplinary discussion regarding the optimal sequencing of systemic and local therapies.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	23-09-2026
	الوقت :	
	الطبيب المعالج :	
يعتمد ,		

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول
الرقمي

رسوم الاستعلام 20 جنية

جهاز الإصدار: فرع الجيزة

تاريخ الإصدار: 2026-6-23

إلى من يهمه الأمر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) نجاهة نوفيق ذكي سعد بطاقة رقم 26604092100325

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2026-6-23

الموظف المختص

احمد ياسر



إفادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،



مسلسل 2005099

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي

Patient Name:	Nagat Tawfeek Zaky Saed		
Patient Id:	26604092100325	Sex:	F
Study:		Age:	60Y 2M
Date:	22/06/2026	Accession:	
Dear Prof. Dr.	Thank you for referring this case.		

Bilateral breast sono-mammography REVEALED:-

- **Mammography:**
- **ACR: A**
- Right breast shows spiculated isodense lesion , no microcalcifications by ultrasound revealed ill-defined solid hypoechoic lesion measures 12x8mm cm with internal vascularity located at axillary tail in position.right axillary lymph nodes with rounded shape and thickened cortex .
- Left breast : No evidence of suspicious micro calcification or masses normal breast parenchyma on ultrasound with no evidence of cysts nor solid masses seen
- Left axilla showing reactive LNs with preserved fatty hila

Conclusion :

- Right breast suspicious lesion , BIRADS 5 For Biopsy .
- Normal left breast, BIRADS 1.

Dr.Sanaa Mohammed ,Msc,FEBR

Patient Name	نجاه توفيق ذكي	Case No.	328373
Sex/Age	Female 60 Y	Patient No.	24099
Registered Date	24/6/2026 01:43:57 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/7/2026 01:29:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/7/2026 10:59:04 AM	Pathology No.	1996/26

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 24/06/2026, at 11:00 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 0.8 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- **Histologic type:** Invasive duct carcinoma.
- **Histologic grade:** 1 (Differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 1).
- **Ductal carcinoma in situ:** Absent.
- **Angioinvasion:** Absent.
- **Perineural invasion:** Absent
- **Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** Mild.

Results:

* **IPT (All controls showed appropriate reactivity):**

- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).

Patient Name	نجاة توفيق ذكي	Case No.	328373
Sex/Age	Female 60 Y	Patient No.	24099
Registered Date	24/6/2026 01:43:57 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/7/2026 01:29:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/7/2026 10:59:04 AM	Pathology No.	1996/26

- Her2: Faint incomplete membrane reaction in less than 10% of tumor cells (Ultra-low, score 0+).
- Ki67%: 15%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 1.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Ultra-low (score 0+).
- Ki67%: 15%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

ACR: A

CAP

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - لوريشان النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Nisar El Qudema - Cairo, Egypt

Patient Name	نجاه توفيق ذكي	Case No.	328373
Sex/Age	Female 60 Y	Patient No.	24099
Registered Date	24/6/2026 01:43:57 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/7/2026 01:29:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/7/2026 10:59:04 AM	Pathology No.	1996/26

Signature:
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

Patient Name	نجاه توفيق ذكي	Case No.	328373
Sex/Age	Female 60 Y	Patient No.	24099
Registered Date	24/6/2026 01:43:57 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/7/2026 01:29:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/7/2026 10:59:04 AM	Pathology No.	1996/26

Client Data: Right breast mass (BIRADS-5):

Nature of Specimen: Tre-cut biopsy, collected on 24/06/2026, at 11:00am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 0.8 cm long, totally submerged.

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبلى رقم (987) - مركز قيس النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mide El Qulema - Cairo, Egypt

Technique:

Sections stained & fixed in paraffin block for immunohistochemistry using Benchmark
 HT Flex system (DAKO).

- ER clone (1E7), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Patient's Name: Najah Tawfiq Zaki Saad
Date: 2026-08-22
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

I- CHEST:

- Right axillary ill-defined soft tissue measuring about 1.5x1.7cm with prominent right axillary lymph nodes
- Bilateral few scattered subcentimetric pulmonary nodules, largest one seen at left lower lobe anterior basal segment measuring about 8mm.
- Right lower lobe osteophyte related reticulations
- no consolidation or cavitation.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No plural or pericardial collection.
- No gross cardiomegaly
- Dorsal spondylosis

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Bilateral cortical renal cysts
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Lumbar spondylosis
- L4 sclerotic focus
- Few small vertebral lytic bony lesions

Opinion:

- Right axillary ill-defined soft tissue with prominent right axillary lymph nodes
- Bilateral few scattered subcentimetric pulmonary nodules for follow up.
- Few small vertebral lytic bony lesions for bone scan correlation

Dr.Nourhan Ewis

Patient's Name: Najah Tawfiq Zaki Saad
Date: 2026-08-22
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

I- CHEST:

- Right axillary ill-defined soft tissue measuring about 1.5x1.7cm with prominent right axillary lymph nodes
- Bilateral few scattered subcentimetric pulmonary nodules, largest one seen at left lower lobe anterior basal segment measuring about 8mm.
- Right lower lobe osteophyte related reticulations
- no consolidation or cavitation.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No plural or pericardial collection.
- No gross cardiomegaly
- Dorsal spondylosis

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Bilateral cortical renal cysts
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Lumbar spondylosis
- L4 sclerotic focus
- Few small vertebral lytic bony lesions

Opinion:

- Right axillary ill-defined soft tissue with prominent right axillary lymph nodes
- Bilateral few scattered subcentimetric pulmonary nodules for follow up.
- Few small vertebral lytic bony lesions for bone scan correlation

Dr.Nourhan Ewis

Patient's Name: Najah Tawfiq Zaki Saad
Date: 2026-08-22
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

I- CHEST:

- Right axillary ill-defined soft tissue measuring about 1.5x1.7cm with prominent right axillary lymph nodes
- Bilateral few scattered subcentimetric pulmonary nodules, largest one seen at left lower lobe anterior basal segment measuring about 8mm.
- Right lower lobe osteophyte related reticulations
- no consolidation or cavitation.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No plural or pericardial collection.
- No gross cardiomegaly
- Dorsal spondylosis

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Bilateral cortical renal cysts
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Lumbar spondylosis
- L4 sclerotic focus
- Few small vertebral lytic bony lesions

Opinion:

- Right axillary ill-defined soft tissue with prominent right axillary lymph nodes
- Bilateral few scattered subcentimetric pulmonary nodules for follow up.
- Few small vertebral lytic bony lesions for bone scan correlation

Dr.Nourhan Ewis

جوستاف
روستام
٨٨



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الجمهورية العربية السورية
سجل

09/20/2026

MDT FORM

Name:	تشي سند TAWFIK نهج	MRN:	12976
Age:	50 Y	ID:	26604092100325
Menopausal Sta:	post	Phone:*	01025938805
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	-ve
Gender		Reason Of MDT:	new
CO Morbidity:	HTN	ECOG Performance Status	0 0 1 2 3 4
Surgical History:*	appendectomy		

Clinical Data:

BX:	IDC 1
ER:	8/8
PR:	8/8
HER2:	0
KI67:	15%

History:	
----------	--

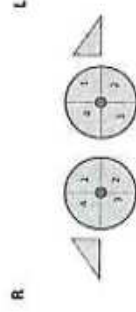
Sonomammography:	rt breast mass 12 * 8 mm
------------------	--------------------------

Biomarker/Molecular	luminal A
---------------------	-----------

Mets Workup:	ct cap small vertebral lytic lesion bone scan multiple focal lesions highly suspicious for metastatic bone disease
--------------	---

Recommendations:	
------------------	--

MDT Outcome & Plan	FOR MRI WHOLE SPINE AND BRAIN IF FREE NA AC X4TX4 PORTA-CTH CLIPPING THE LT WLE+ALND IF POSITIVE METS FOR RE-MDT
--------------------	--



TNM

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

T1 N1 M X

skin redness in UJQ not including more than 1/3 breast

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د محمد كيلاني	د محمد انور لاري	د ترميز ومضان	

Name : Nagaa Tawfiq Zaki Saad

Date : 10-09-2026 03:14

Branch : Dokki

Medical No. : 459001

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Ins.Company : تعاقد مستشفى

NUCLEAR MEDICINE BONE SCAN REPORT

Clinical Indication: 60-year-old female with newly diagnosed right breast mass.
Referred for baseline skeletal staging.

Procedure: Whole-body planar bone scintigraphy, anterior and posterior views,
following intravenous administration of 99mTc-MDP.

Findings:

- Scattered focal areas of increased radiotracer uptake are identified in the left parietal bone, lower right rib margin, multiple lumbar vertebral bodies, right acetabular region/pelvic ring, and mid-diaphysis of the left femur.
- Renal excretion is prompt and symmetric. No abnormal soft tissue uptake.

Impression:

- Multiple focal skeletal lesions involving the skull, axial, and appendicular skeleton—highly suspicious for metastatic bone disease secondary to the primary breast neoplasm, for clinical/radiological correlation.
- Follow up as clinically indicated.

Dr. Alaa Nagi

MD Nuclear Medicine

Patient's Name: Najah Tawfiq Zaki Saad
Date: 2026-08-22
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

I- CHEST:

- Right axillary ill-defined soft tissue measuring about 1.5x1.7cm with prominent right axillary lymph nodes
- Bilateral few scattered subcentimetric pulmonary nodules, largest one seen at left lower lobe anterior basal segment measuring about 8mm.
- Right lower lobe osteophyte related reticulations
- no consolidation or cavitation.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No plural or pericardial collection.
- No gross cardiomegaly
- Dorsal spondylosis

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Bilateral cortical renal cysts
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Lumbar spondylosis
- L4 sclerotic focus
- Few small vertebral lytic bony lesions

Opinion:

- Right axillary ill-defined soft tissue with prominent right axillary lymph nodes
- Bilateral few scattered subcentimetric pulmonary nodules for follow up.
- Few small vertebral lytic bony lesions for bone scan correlation

Dr.Nourhan Ewis

Patient Name:	Nagat Tawfeek Zaky Saeed		
Patient Id:	26604092100325	Sex:	F
Study:		Age:	60Y 2M
Date:	22/06/2026	Accession:	
Dear Prof. Dr.		Thank you for referring this case.	

Bilateral breast sono-mammography REVEALED:-

- **Mammography:**
 - **ACR: A**
 - Right breast shows spiculated isodense lesion , no microcalcifications by ultrasound revealed ill-defined solid hypoechoic lesion measures 12x8mm cm with internal vascularity located at axillary tail in position. right axillary lymph nodes with rounded shape and thickened cortex .
 - Left breast : No evidence of suspicious micro calcification or masses normal breast parenchyma on ultrasound with no evidence of cysts nor solid masses seen
 - Left axilla showing reactive LNs with preserved fatty hila
- Conclusion :**
- Right breast suspicious lesion , BIRADS 5 For Biopsy .
 - Normal left breast, BIRADS 1.

Dr.Sanaa Mohammed ,Msc,FEBR

Patient Name	نبهه توفيق نسي	Case No.	328373
Sex/Age	Female 60 Y	Patient No.	24099
Registered Date	24/6/2026 01:43:57 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/7/2026 01:29:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/7/2026 10:59:04 AM	Pathology No.	1996/26

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 24/06/2026, at 11:00 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 0.8 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
 - ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 1 (Differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 1).
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).



Patient Name	نحاده توفيق نكي	Case No.	328373
Sex/Age	Female 60 Y	Patient No.	24099
Registered Date	24/6/2026 01:43:57 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/7/2026 01:29:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/7/2026 10:59:04 AM	Pathology No.	1996/26

- Her2: Faint incomplete membrane reaction in less than 10% of tumor cells (Ultra-low, score 0+).
- Ki67%: 15%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 1.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Ultra-low (score 0+).
- Ki67%: 15%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.



Patient Name	نباهة توفيق ندى	Case No.	328373
Sex/Age	Female 60 Y	Patient No.	24099
Registered Date	24/6/2026 01:43:57 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/7/2026 01:29:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/7/2026 10:59:04 AM	Pathology No.	1996/26

Signature:

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche- Alser El Qadima - Cairo, Egypt

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول
الرقمي

رسم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2026-6-23

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين ومنظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعي

و البحث تبين أن

السيد (ة) نجاة نوفيق ذكي سعد بطاقة رقم 26604092100325
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطابات من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المتفعله بالتأمين الصحي صدر- هذا الخطاب دون اننى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه : 2026-6-23

الموظف المختص

احمد ياسر



مسلسل 2005099

قاعدة مركز نظم المعلومات
يعتمد

الخطاب سدرى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي